

סמינר הסטאז׳רים · מפגש 2 מתוך 4

סדנת תפירה

מהמגש של חדר הניתוח ועד הקשר הראשון

המערך הכירורגי · המרכז הרפואי קפלן

מבנה הסדנה

45 דקות, רובן בידיים

10 דקות

הסבר

מכשירים, להבים, חוטים, חתכים ותפרים

35 דקות

תרגול בעמדות

תפר פשוט, רציף, מזרן ותת-עורי

5 דקות

סיכום

מה הולך איתכם לחדר הניתוח

המכשירים הבסיסיים

מחזיק מחט

אוחזים בטבעות באגודל ובקמיצה. לא נוגעים במחט באצבעות

פינצטה

עם שיניים לעור (Adson). בלי שיניים לרקמה עדינה (DeBakey)

מספריים

Metzenbaum. קשה לחוטים ורקמה Mayo לרקמה עדינה בלבד

המוסטט

סגירה על כלי דם ואחיזה. Mosquito או Kelly

מפשק

ידני (Army-Navy) או עצמי (Weitlaner)

ידית סכין

ידית 3 ללהבים קטנים, ידית 4 ללהבים גדולים

חדר הניתוח

סוגי להבים

להב 10

מעוגל וגדול. חתכי עור ארוכים

להב 11

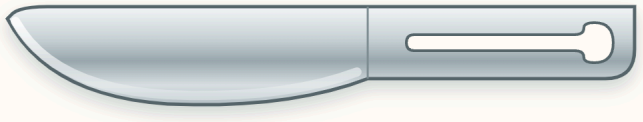
מחודד ומשולש. דקירה, ניקוז מורסה, פתח לנקז

להב 15

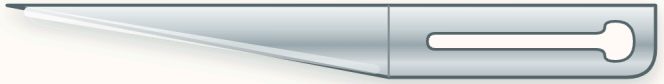
קטן ומעוגל. חתכים קצרים ומדויקים

להבים 20 עד 22 גדולים יותר ומתאימים לידית 4. חותכים בתנועה אחת רציפה, בניצב לעור

להב 10 קצה מעוגל וגדול



להב 11 משולש, קצה חד



להב 15 קצה קטן ומעוגל



חוטים

שלוש שאלות על כל חוט

1

נספג או לא נספג

נספג: מתפרק בגוף בתוך שבועות עד חודשים. לא נספג: נשאר, או מוסר כמו תפרי עור

2

חד-סיבי או שזור

חד-סיבי (מונופילמנט) חלק ופחות שומר חיידקים. שזור קל לקשירה ומחזיק קשר טוב

3

עובי

מסומן במספר. כמה שיותר אפסים, החוט דק יותר

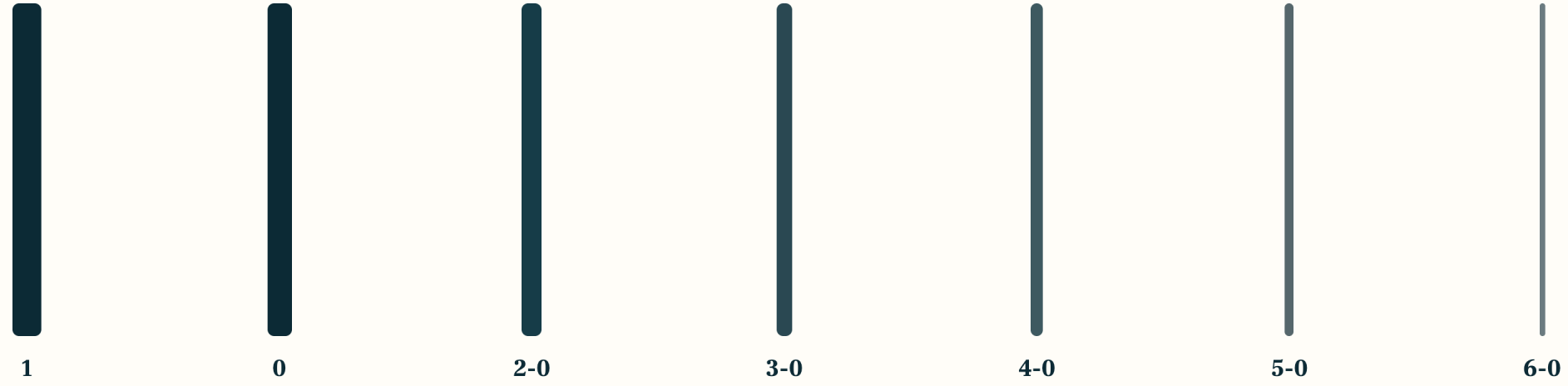
החוטים שתראו הכי הרבה

חוט	סוג	שימוש נפוץ
Vicryl	שזור, נספג	רקמה תת-עורית, קשירות, מעי
Monocryl	חד-סיבי, נספג מהר	תפר עור תת-עורי
PDS	חד-סיבי, נספג לאט	סגירת פציה
Prolene	חד-סיבי, לא נספג	בקע ורשת, כלי דם, עור
Nylon	חד-סיבי, לא נספג	תפרי עור
Silk	שזור, לא נספג	קיבוע נקזים, קשירות

השמות הם מסחריים. הבחירה בפועל תלויה במנתח ובמוסד

חוטים

עובי החוט: יותר אפסים, חוט דק יותר



פציה

0 עד 1

עור בגוף ובגפיים

3-0 עד 4-0

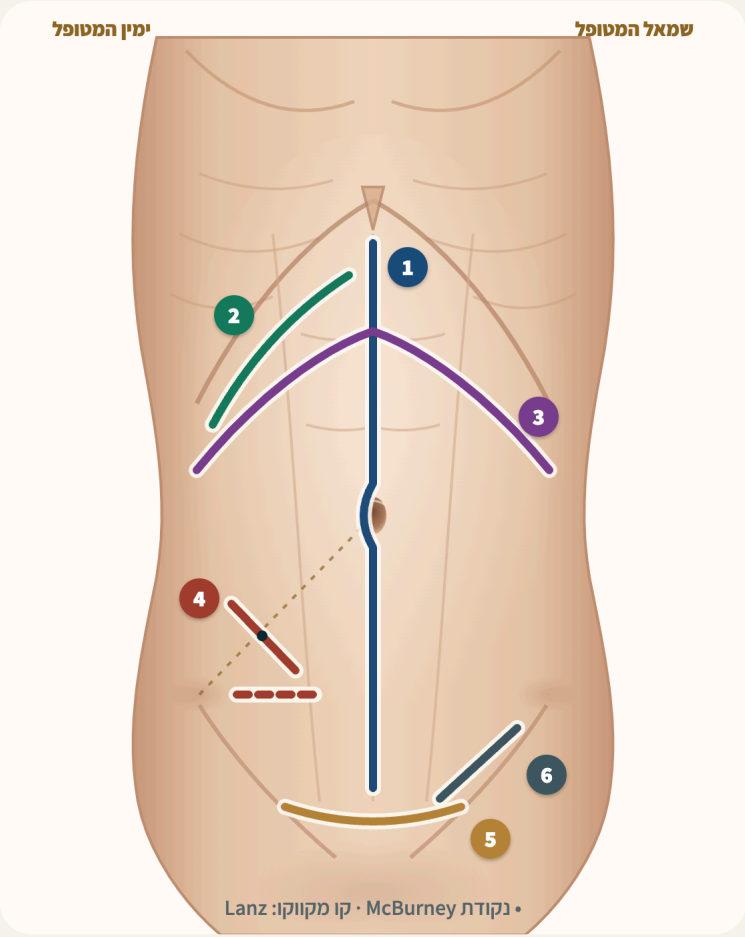
פנים

5-0 עד 6-0

מחט

חותכת לעור. עגולה לרקמה רכה, מעי וכלי דם

סוגי חתכים



1 קו אמצע (לפרוטומיה)
דרך הלינאה אלבה. מהיר, רחב וגמיש. הנפוץ ביותר בניתוח דחוף

2 Kocher
2 אצבעות מתחת לקשת הצלעות הימנית. כיס מרה וכבד

3 Chevron
תת-צלעי דו-צדדי שמתחבר באמצע. כבד ולבלב

4 McBurney / Lanz
ברבע הימני התחתון, בשליש החיצוני של הקו מה-ASIS לטבור. Lanz: רוחבי באותה נקודה

5 Pfannenstiel
רוחבי, 2 אצבעות מעל הערווה. קיסרי וגינקולוגיה. קוסמטי

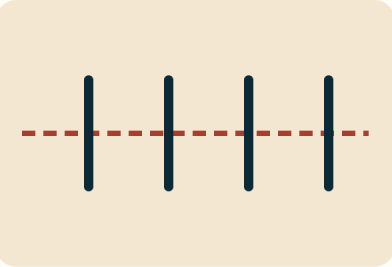
6 מפשעתי
מקביל לרצועה המפשעתית. תיקון בקע

טכניקה

איך תופרים: חמישה עקרונות

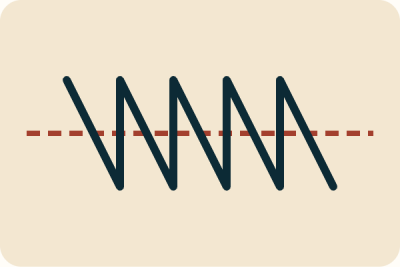
1	**אחיזה**	אוחזים את המחט בשליש האחורי שלה, בקצה מחזיק המחט
2	**כניסה**	המחט נכנסת לעור בזווית של 90 מעלות
3	**תנועה**	מסובבים את פרק כף היד ועוקבים אחרי הקימור של המחט
4	**סימטריה**	אותו מרחק מהשוליים ואותו עומק בשני הצדדים
5	**מתח**	מקרבים את השוליים, לא חונקים. שוליים מעט מורמים (eversion)

ארבעת התפרים הבסיסיים



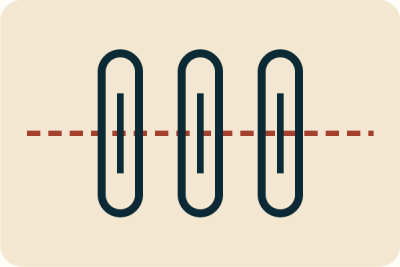
תפר פשוט נפרד

הבסיס. כל תפר עומד לבד. מתאים כמעט לכל פצע



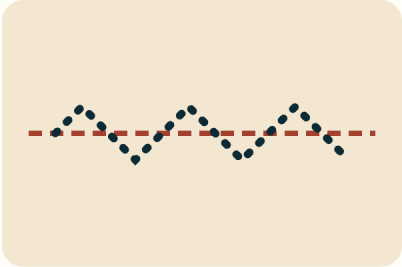
תפר רציף

מהיר, מפזר מתח לאורך כל הפצע



מזרן אנכי

הופך את השוליים החוצה. טוב למתח ולעור דק



תת-עורי

בתוך העור. תוצאה קוסמטית, בלי תפרים להוציא

טכניקה

קשר מכשיר בארבעה צעדים

1
סיבוב כפול
כורכים את החוט פעמיים סביב מחזיק המחט (קשר מנתח)

2
תופסים ומושכים
תופסים את הקצה הקצר ומושכים לצד השני

3
סיבוב הפוך
סיבוב אחד, בכיוון ההפוך

4
נועלים
עוד זריקה אחת לפחות. בחוט חד-סיבי עוד כמה

קשר מרובע ושטוח. כל זריקה בכיוון הפוך לקודמת. לא מושכים חזק מדי

אחרי הניתוח

מתי מוציאים תפרי עור

פנים	קרקפת	גוף	גפיים	מעל מפרקים
5 ימים	7 עד 10 ימים	10 עד 14 ימים	10 עד 14 ימים	14 ימים

טווחים מקובלים. מתאימים לפי מצב הפצע, מתח, סוכרת וסטרואידים

תרגול

עכשיו לידיים

עמדות תרגול

- עמדה 1: תפר פשוט נפרד, 10 תפרים
- עמדה 2: תפר רציף
- עמדה 3: מזרן אנכי
- עמדה 4: תת-עורי
- עמדה 5: קשר מכשיר, 10 פעמים

מה בודקים בתפר טוב

- שוליים מקורבים ומעט מורמים
- מרווחים שווים
- קשרים שטוחים ולא חונקים
- קצוות חוט באורך אחיד
- המחט לא נגעה באצבעות

הערה

על המקורות

המצגת מבוססת על עקרונות סטנדרטיים בטכניקה כירורגית בסיסית. סוגי החוטים, העוביים וזמני הוצאת התפרים הם טווחים מקובלים, והבחירה בפועל נקבעת לפי המנתח, המוסד והמטופל